

Abordagem de Náuseas e Vômitos



ROTINA CLÍNICA

Introdução

- ◈ A náusea, a sensação desagradável de estar prestes a vomitar, pode ocorrer isoladamente ou acompanhar o vômito (a expulsão forçada do conteúdo gástrico), dispepsia ou outros sintomas gastrointestinais;
- ◈ A náusea se correlaciona com uma mudança na atividade mioelétrica gástrica normal de três ciclos por minuto para frequência aumentada (taquigastria) ou frequência reduzida (bradigastria).



Introdução

- ◆ Os vômitos geralmente são precedidos por náuseas;
- ◆ Vômitos não precedidos por náuseas, conhecidos como “vômitos em jato”, são classicamente, associados à hipertensão intracraniana (HIC);
- ◆ O ato de vomitar é resultante de uma **série de ações**:
- ◆ Estímulo aferente → Contração de músculos abdominais, diafragmáticos e respiratórios contra a glote fechada → Pressão intra-abdominal positiva, que força o conteúdo gástrico para o esôfago.

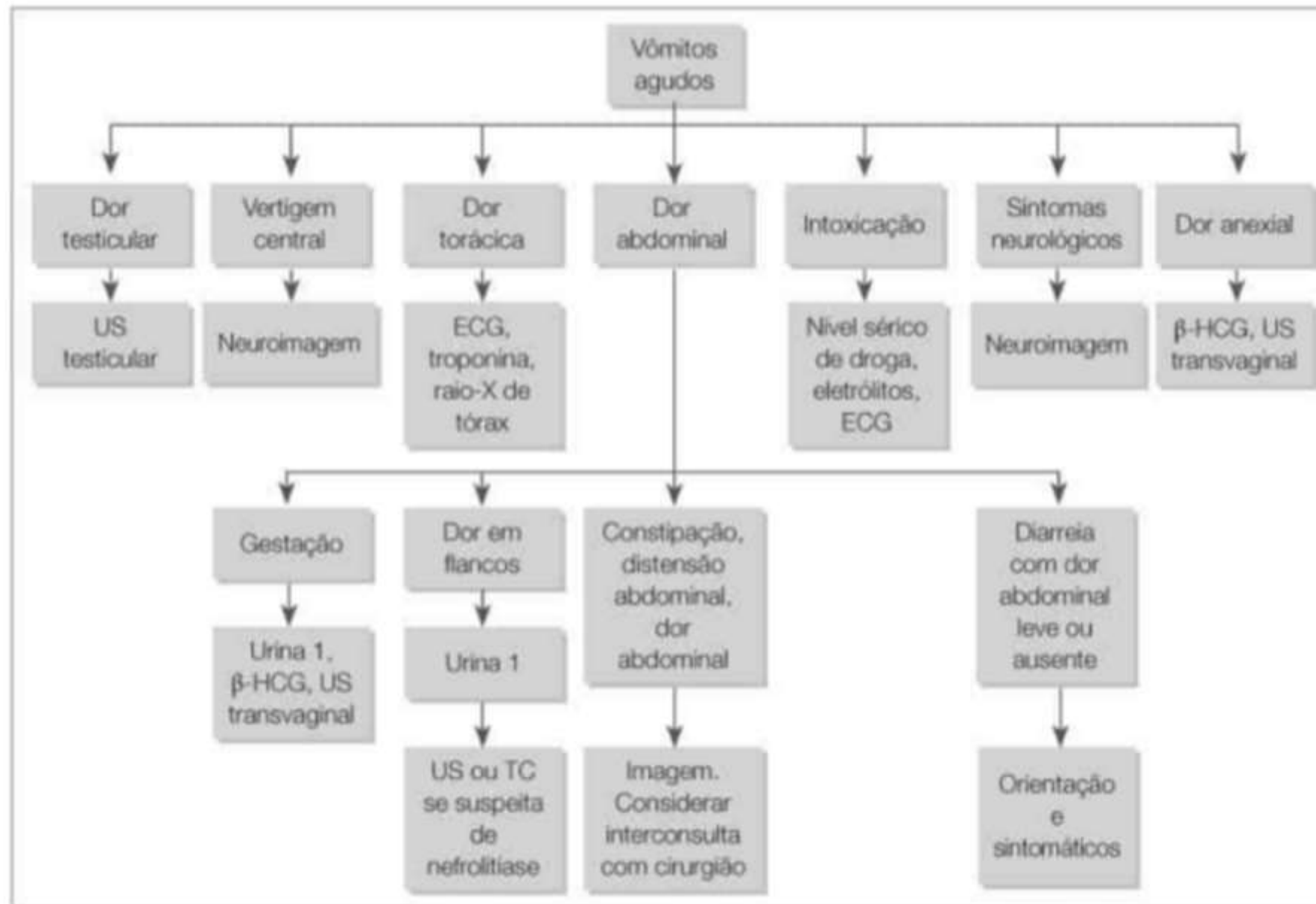
Principais etiologias

- ◈ **Medicações:** Quimioterápicos, antimicrobianos, opioides (40 a 70% dos pacientes em uso), uso abusivo de álcool;
- ◈ **Alterações peritoneais e intestinais:** Obstrução mecânica, úlcera péptica, pancreatite, colecistite, isquemia mesentérica, alterações funcionais como gastroparesia e dispepsia;
- ◈ **Causas infecciosas:** Gastroenterites, quadros infecciosos com toxemia;
- ◈ **Causas de SNC:** Enxaqueca, HIC, doenças psiquiátricas, doenças vestibulares.

Principais etiologias

- ◈ **Causas endócrinas e metabólicas:** Insuficiência Adrenal, hipertireoidismo, uremia;
- ◈ **Vômitos pós-cirurgia;**
- ◈ **Síndrome dos Vômitos Cíclicos** (episódios breves de vômito intratável, intercalado com períodos assintomáticos);
- ◈ **Infarto Agudo do miocárdio, entre outras etiologias.**





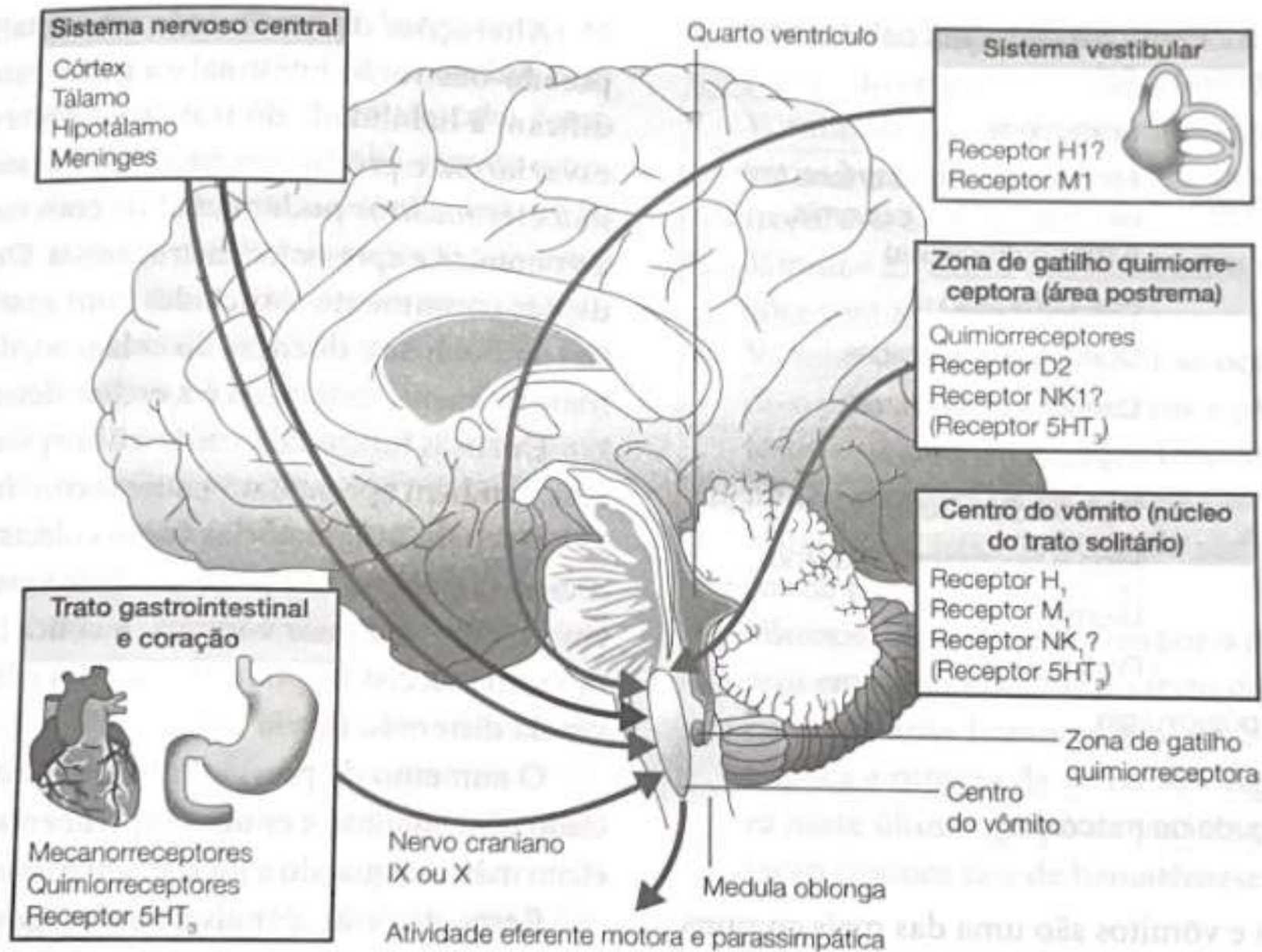
▷ FIGURA 1 Etiologias de vômitos agudos.

Fisiopatologia dos Vômitos

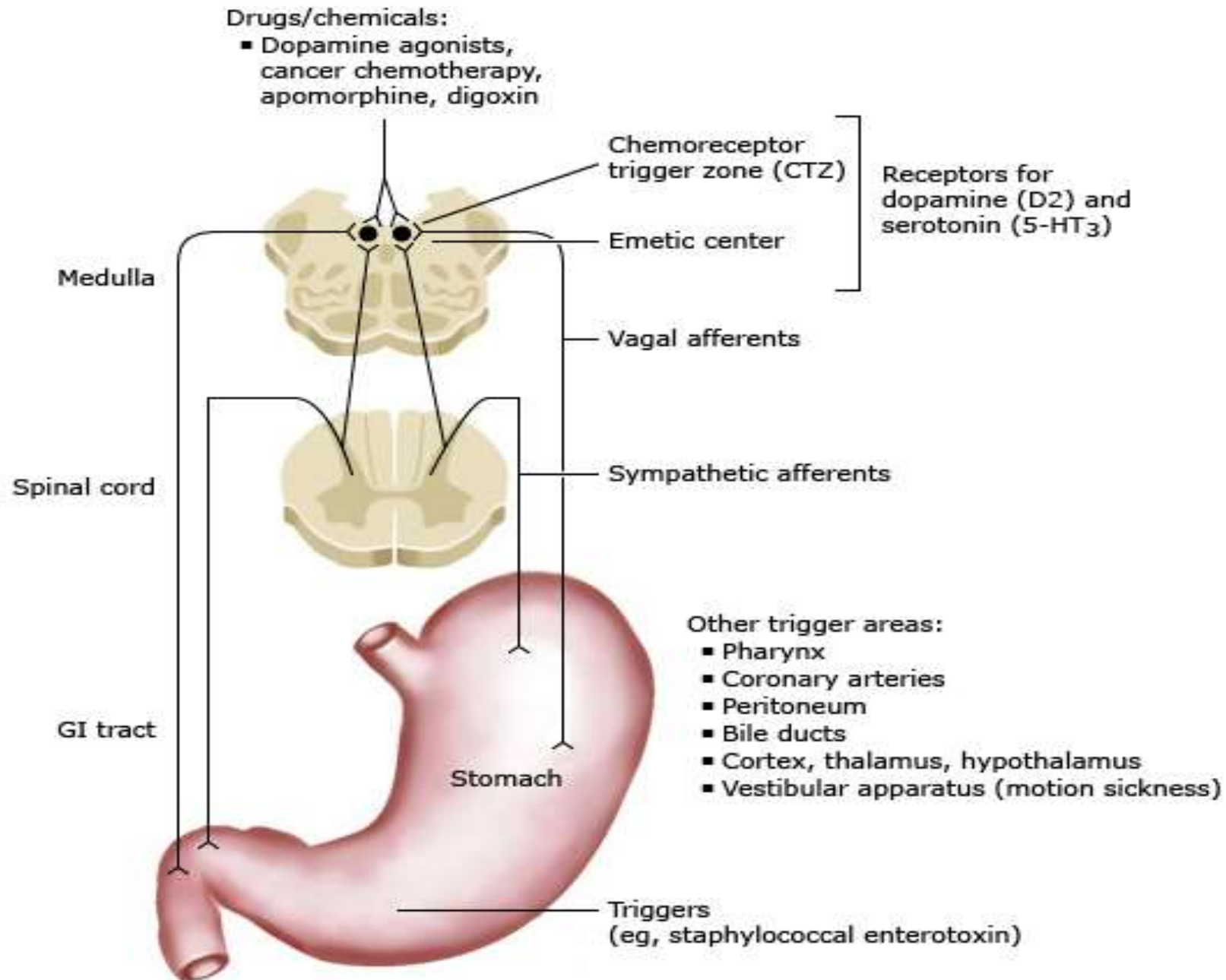
- ◊ O centro do vômito no SNC recebe quatro aferências de quatro fontes:
- ◊ **1) Fibras aferentes vagais e esplâncnicas originadas no TGI** (receptores 5 HT3): Essas fibras são estimuladas por distensão da mucosa de vias biliares e gastrointestinais, por irritantes gástricos (salicilatos, toxinas) e por irritantes peritoneais (abdome agudo inflamatório);
- ◊ **2) Sistema Vestibular** (receptores histamínicos H1 e muscarínicos colinérgicos M1): Fibras estimuladas por movimento e por infecções.

Fisiopatologia dos Vômitos

- ◈ **3) Zona Postrema da Medula (quimiorreceptores em contato com sangue e líquido):** Área estimulada por agentes quimioterápicos, drogas, toxinas, uremia, acidose, hipóxia, radioterapia;
- ◈ **4) Outros receptores do SNC:** Associados com odores, experiências emocionais, como por exemplo, no caso dos vômitos que ocorrem como antecipação a quimioterapia.



▷ FIGURA 1 Adaptada de Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Basic & clinical pharmacology. 11.ed.



Abordagem

- ◈ Avaliar a necessidade ou não de reposição volêmica (avaliar turgor da pele, hidratação de mucosas e sinais vitais ao exame físico);
- ◈ Caso necessário, fazer uso de soluções cristaloides (SF 0,9%, por exemplo);
- ◈ Direcionar o tratamento com base na possível fisiopatologia associada ao quadro de náuseas e vômitos.

Medicações mais utilizadas

- ◆ Anti-histamínicos (H1 e receptores muscarínicos):
- ◆ Dimenidrato (Dramin®, DraminB6®);
- ◆ Oral em Cápsulas de 25 mg e 50 mg (Dose máxima de 400 mg/dia);
- ◆ Parenteral: Ampolas de 10 mL, contendo Dimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina + Frutose + Glicose;
- ◆ **Classe B (Gestação) e uso liberado na lactação;**

Medicações mais utilizadas

- ◆ Antagonistas dopaminérgicos (D2):

- ◆ Bromoprida (Digesan®) e Metoclopramida (Plasil®);

- ◆ Bromoprida: Cápsulas e comprimidos com 10 mg; Solução Oral 1 mg/ml ou 4 mg/mL e Ampola com 2 mL e 5 mg/mL (10 mg);

- ◆ **Classe C na Gestação e uso não recomendado na lactação.**

- ◆ Metoclopramida: Comprimidos com 10 mg, Solução oral 4 mg/mL e ampolas com 2 mL e 5 mg/mL (10 mg);

- ◆ **Classe B na Gestação e uso não recomendado na lactação.**

Medicações mais utilizadas

♦ Antagonistas Serotoninérgicos (5HT):

- ♦ Ondansetrona (Vonau®);
- ♦ Comprimido orodispersível com 4 mg e 8 mg, comprimido revestido com 4 mg e 8 mg, solução oral 0,8 mg/mL, solução injetável com 2 mg/mL, com ampolas de 2 mL e 4 mL;
- ♦ Uso não recomendado no 1º trimestre de gestação e classe B nos demais trimestres;
- ♦ Uso na lactação deve considerar risco é benefícios (não se sabe se é excretada no leite materno).

Medicação	Preço por ampola (R\$)
Bromoprida 10 mg	2,32
Ondansetrona 4 mg	3,58
Dimenidrato (Dramin B6)	26,58* - Maioria esgotado na busca
Metoclopramida 10 mg	1,24

Abordagem Direcionada

- ◇ **Vômitos associados a QT:**

- ◇ Antagonistas Serotoninérgicos +/- Corticoide (potencializador de efeito):
- ◇ Ondansetrona 4 mg, 8 mg (VO ou EV); Dexametasona 10 mg EV;

- ◇ **Vômitos associados a gastroparesia (diabéticos):**

- ◇ Antagonistas dopaminérgicos:
- ◇ Domperidona 10 mg, VO; Bromoprida 10 mg EV;
- ◇ Metoclopramida 10 mg; EV ou VO; Doses superiores a 10 mg: Diluir em 100 mL de SF 0,9% e infundir em 10 a 15 minutos.

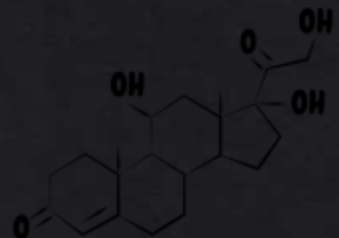
Abordagem Direcionada

- ◆ Vômitos em gestantes – São grupo B:

- ◆ Anti-histamínicos (H1) +/- Antagonistas da Serotonina:
- ◆ Dimenidrato 30 mg EV (preferência); Ondansetrona 4 mg, 8 mg;

- ◆ Cinetose e origem vestibular:

- ◆ Anti-histamínicos (H1) +/- Anticolinérgicos do sistema vestibular
- ◆ Dimenidrato 30 mg EV; Escopolamina (Hioscina) 10 mg EV;



Abordagem Direcionada

- ◆ Vômitos no pós operatório:
- ◆ Ondansetrona 4 mg, 8 mg VO ou EV;
- ◆ Os antagonistas serotoninérgicos atuam como “coringas”, sendo utilizado nas mais diversas situações e nos pacientes com história de reação extrapiramidal com uso de outras medicações.



E a reação extrapiramidal?

- ◆ **Relacionada com a ação antidopaminérgica** e ao bloqueio dos efeitos inibitórios periféricos da dopamina sobre as fibras musculares do trato digestivo por meio do antagonismo de receptores dopaminérgicos do tipo D2 e ao bloqueio desses receptores em regiões centrais como a área postrema;
- ◆ **Administrar Bromoprida e Metoclopramida em diluições maiores (100 mL) e por mais tempo (> 10/15 minutos) pode reduzir sua ocorrência;**
- ◆ O que podemos ver: Acatisia (transtorno de movimento relacionado ao sistema motor e caracterizado por sensação subjetiva de inquietude interna, irritabilidade ou disforia que podem ser intensas);
- ◆ Tratamento: Biperideno (Anticolinérgico com efeito marcante no sistema nervoso central).

▷ TABELA 4 Tratamento de náuseas e vômitos

Etiologia	Mecanismo	Principais mediadores	Tratamento sugerido
Constipação, pseudo-obstrução intestinal, íleo paralítico	Distensão da parede intestinal	Receptores de dopamina D ₂ no trato gastrointestinal	Antieméticos antidopaminérgicos (metoclopramida, haloperidol)
Radiação, quimioterapia, infecção, invasão direta de tumores	Insulto da parede intestinal	Receptores de serotonina 5HT ₃ no trato gastrointestinal	Antagonistas serotoninérgicos (ondansetron)
Drogas, toxinas bacterianas	—	Receptores D ₂ , 5HT ₃ , neurocinina tipo 1 na zona do <i>trigger</i>	Antieméticos antidopaminérgicos e antagonistas serotoninérgicos
Cinetose, labirintite	Desordens do labirinto e movimento	Receptores de histamina H ₁ e muscarínicos no sistema vestibular	Anti-histamínicos (difenidramina) e anticolinérgicos (escopolamina, prometazina)
Transtorno de ansiedade generalizada	—	Desconhecido	Benzodiazepínicos
Aumento da pressão intracraniana	—	Desconhecido	Glicocorticoides
Gestação	—	Desconhecido	Anti-histamínicos (difenidramina)

Referências

- ◈ Approach to the adult with nausea and vomiting – UpToDate;
- ◈ Medicina de Emergência FMSUP – 17ª Edição.